EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69023
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-12 13:00:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BRUDY AGNA VERA SILVA			**RUN**	: 11.001.261-6
F.Nac	: 31-05-1965	**Edad**	: 58 AÑOS, 2 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: HUENUTIL CENTRO			**Comuna**	: NIQUEN
Previsión	: FONASA C	**Teléfono**	: 979091713		
Fecha Ingreso	: 31-07-2023	**Fecha Egreso**	: 2023-08-12 13:00:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.9-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Hemorragia lentículo-talámica derecha, obs hipertensiva
-Obs transformación hemorragica de infarto isquémico***

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con ant de HTA y DLP, el 30/07/23 se acuesta a las 22 hrs bien, despierta a las 1 am del 31/7/23 con disartria, confusión y hemiparesia severa izquierda. Llega a HSC con disartria y hemiparesia severa izquierda, PAS 200, se indica labetalol ev, TAC cerebro HIC lentículo talámica derecha de 15 cc, con leve hemoventriculo. Es derivada a HCHM donde ingresa a IPC para manejo. requiere BIC Labetalol y manejo AntiHTA para PAS 130-140, manejada inicialmente en TIM/UPCA con requerimientos de manejo activo PA, sin complicaciones, sin deterioro ni indicación neuroquirúrgica. El 7/8/23 se traslada a UTAC para continuar manejo, sin requerimiento de medicación antihipertensiva ev, sin deterioro neurológico, con sd confusional hiperactivo, con hemiplejia FBC derecha y disfagia moderada-severa, paciente estable, en condiciones de traslado a su centro de origen para gestionar rehabilitación y manejo médico.

Evolución
Paciente BEG, HDN con HTA moderada, eupneica, afebril, RS al monitor, estable en déficit neurológico según lo descrito en informe de traslado, no refiere molestias.
Logra sedestación estable con 2 operadores. Evaluación fonoaudiológica concluye capacidad de deglutir papilla y de líquidos con maniobra mentón-pecho. Se decide retirar SNG.
TC cerebro s/c muestra regresión de hemorragia lentículo-talámica derecha, con edema vasogénico perihematoma, compresión de VL ipsilateral sin colapsarlo ni generar hidrocefalia 2°, sin hemoventrículo, desviación de linea media 1-2 mm.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 12/8/23, IC HODOM y control ambulatorio en policlínico Neurología. Previo al alta se realizará angioTC cerebro y cuello para descartar potenciales malformaciones vasculares.

PLAN DE MANEJO:

-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12h

2. -Amlodipino 10 mg/d
3. -Metildopa 250 mg c/12h
4. -Carvedilol (25 mg) 1/2 comp c/12h
5. -Hidroclorotiazida 50 mg/d
6. -Quetiapina 25 mg/noche SOS en caso de insomnio o agitación
7. -Famotidina 40 mg/noche
8. -No usar aspirina o anticoagulantes

EXÁMENES Y RESULTADOS

11/8/23
-Crea 0.7 MDRD 115.83 Uremia 76
-CKMB 10 CKT 87
-ColT 276 HDL 31 LDL 201 VLDL 43.8 TG 219
-Lact 0.9
-PCR 34.4
-Na 144 K 4 Cl 108
-Hb 12.1 Leu 7800 Plaq 205000 Seg 67
-INR 1.16 TTPA 26
-Trop 4 Hb glic 6.5

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación conservadas, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR, 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, atención N, OTE, lenguaje N, gnosias N, praxias N
-PC: CV impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha moderada a severa, disartria leve, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina simétrcia, fuerza ECM M5 bilateral y trapecios M5 a derecha M0 a ixzq, lengua de motilidad normal
-Motor: BC derecho M5, BC izq M0, RCP extensor izquierdo y flexor derecho
-Sensitivo: hipoestesia táctil severa FBC izquierda
-Cerebelo: conservado a derecha, n/e a izquierda por plejia
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO